

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	暫時性腦缺血 Transient Ischemic Attacks; TIA				
編號	A31000-Q03-W-A02	制定者	R12 林碧嵐	公布日期	97 年 05 月 31 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	114 年 10 月 08 日
版本/總頁數	第 4.0 版/10 頁	審查者	曾翊鍵	檢閱日期	114 年 10 月 08 日

一、目的

讓護理人員了解暫時性腦缺血的定義、症狀、常見檢查、常見治療、護理問題與措施以及衛教指導，使具備更適切之照護能力，以提供最佳服務品質。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）定義

暫時性腦缺血(transient ischemic attacks, TIA)俗稱小中風，意指局部腦組織或視網膜缺血造成短暫性神經功能障礙（通常小於 1 小時）。一般發作時間為 2-15 分鐘且神經症狀於 24 小時內恢復。此為嚴重腦中風前的重要警訊之一，如果不及時治療，1/3 的病人可能會演變為腦中風而出現嚴重的癱瘓而危及生命。

（二）症狀

1. 視力模糊。
2. 感覺運動異常。
3. 單側上肢或下肢神經缺損。
4. 單側面部、舌頭感覺異常，雙側面部麻木。
5. 手指、腳單一區域神經缺損發生、麻木、無力，步態不穩。
6. 明顯的無力感或感覺異常。
7. 不自主運動發生。

主題名稱	暫時性腦缺血	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-A02	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	2/10

8. 短暫性神智障礙。
9. 短暫性單眼失明症。
10. 失語症、失讀症、演算障礙、喪失方向感、構音困難。

(三) 常見檢查

1. 頭頸部及縱隔腔部位聽診，若頸部血管或鎖骨下椎動脈、基底動脈狹窄時，多數的病人可聽診到血管雜音(Bruit)。
2. 頸、顱、橈動脈的搏動和觸診，當頭臂動脈或鎖骨下動脈狹窄、阻塞時，同側的頸動脈及橈動脈搏動會減弱或消失。
3. 轉頭試驗：請病人頭後仰後再側彎，出現頭暈、眼震、劃跖試驗陽性、輕度發音困難，表示基底動脈有硬化現象；如果發生傾倒現象，表示基底動脈缺血現象。轉動頭部或抬高患側上肢出現腦缺血現象、單側手臂量不到血壓，表示鎖骨下動脈有狹窄或閉塞，稱為鎖骨下竊血症候群。
4. 頸動脈、顱底動脈超音波：評估頸動脈、顱底動脈血流，檢查血管內是否有斑塊。
5. 斷層掃描(CT)：可呈現出血、血腫、梗塞的區域，或腦室位移、變形的現象。
6. 磁共振造影(MRI)：可觀察到腦組織的橫切面，觀察梗塞的部位、範圍。
7. 血管攝影(cerebral angiography)：可觀察動脈血管的情形。
8. 心臟超音波：若因心臟跳動不規則、心內膜炎在心臟內部形成血液凝塊，凝塊可能會流到腦部而造成血管阻塞而中風。

(四) 常見治療

1. 藥物治療：減少或預防中風以降低永久性之損傷，常用藥物為：
 - (1) 抗凝劑：Heparin、Coumadin。
 - (2) 血小板抗凝劑：Aspirin、Persantin。
 - (3) 類固醇：Prednisolon。
 - (4) 高滲透壓劑：Glybrain、Manniol。
 - (5) 血栓溶解劑：rt-PA(Actilyse)。

主題名稱	暫時性腦缺血	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-A02	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	3/10

2. 手術治療：

- (1) 發現內頸動脈狹窄，可施行頸動脈內膜切除術，將血管內膜剝除，能降低 75% 中風機率。
- (2) 將栓塞切除以重建血管，保存血流供應。
- (3) 顱內-顱外分流術最常做的是表淺中顱動脈與中大腦動脈的分流術，以增加腦部血流供應量。

3. 飲食治療：

- (1) 高纖飲食。
- (2) 低脂肪。
- (3) 低熱量。
- (4) 低鹽。
- (5) 低膽固醇。
- (6) 高鈣。
- (7) 高營養均衡飲食。

4. 控制血壓、控制血糖、控制血脂濃度、控制肥胖，戒菸與運動。

(五) 護理問題

1. 易跌倒／生理因素。
2. 排便異常：便秘／體能活動不足。
3. 身體活動能力異常／神經肌肉障礙、骨骼肌肉障礙。
4. 心肺血流不足／周邊動脈、靜脈血流受抑制。

(六) 護理措施

1. 易跌倒／生理因素。
 - (1) 病人臥床時使用床欄並注意床欄穩固。
 - (2) 降低病床高度。
 - (3) 使用夜燈的設置。
 - (4) 防滑墊使用、止滑鞋的穿著。

主題名稱	暫時性腦缺血	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-A02	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	4/10

- (5) 清除病床到浴室間的障礙物，保持地面乾燥及適當照明。
- (6) 護理人員每班至少兩小時查看病人情形。
- (7) 將尿壺或便盆置於可拿取位置且倒空。
- (8) 讓病人及家屬瞭解目前之行動能力及限制，應採漸進式活動，且須有陪伴者在旁扶助。
- (9) 教導病人使用叫人鈴並放在健側位置。
- (10) 讓病人及家屬瞭解正在服用易導致跌倒的藥物，如：降血壓及安眠藥等。
- (11) 衛教病人在服用藥物後半小時內改變姿勢宜緩慢。
- (12) 必要時依醫囑給予適當的約束。
- (13) 依照顧者該國籍給予預防跌倒照護衛教單張。

2. 排便異常：便秘／體能活動不足

- (1) 應用大便訓練規範執行並記錄評估。
- (2) 教導病人及家屬大便訓練過程並確認皆已瞭解。
- (3) 與病人及家屬分析飲食型態，於經濟許可內，修改飲食內容，增加高纖維食物的比例，如：每天吃含麥麩的食品、每天吃一份高纖維蔬菜、以全麥麵包取代白麵包、多攝取棗子、香蕉或喜愛的新鮮果汁。
- (4) 教導病人記錄 24 小時所有攝取飲食的內容。
- (5) 教導肢體關節活動，最好每天進行兩次主動性全關節活動。

3. 身體活動能力異常／神經肌肉障礙、骨骼肌肉障礙

- (1) 評估身體活動能力異常程度。
- (2) 建議漸進式活動並教導與示範移動技巧。
- (3) 協助並教導病人從主動全關節運動漸進至功能性活動。
- (4) 示範增加活動力的方法及 ROM 等長運動、等張運動。
- (5) 教導活動時注意之安全措施。
- (6) 協助並教導正確使用輔助器。
- (7) 活動後抬高患肢之末梢促進血循，減輕腫脹。

主題名稱	暫時性腦缺血	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-A02	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	5/10

(8)教導病人患肢執行被動關節運動。

(9)教導病人健肢執行主動關節運動。

(10)依醫囑予骨骼肌鬆弛劑。

(11)計劃休息治療與主動身體運動以增進體力及功能。

(12)評值病人身體活動功能活動後反應。

4.心肺血流不足／周邊動脈、靜脈血流受抑制

(1) 評估動脈脈搏的特性並記錄。

(2) 評估皮膚溫度及顏色。

(3) 鼓勵床上肢體或漸進性下床活動。

(4) 長期臥床的病人應協助被動的全關節運動並避免四肢長期受壓迫。

(5) 下肢保持與心臟齊平或低於心臟的位置（動脈血流受抑制）下肢保持與心臟齊平或高於心臟的位置（靜脈血流受抑制）。

(6) 避免長期暴露於冷空氣中，室溫保持攝氏 25 度。

(7) 天冷時穿戴手套或毛襪保暖。

(8) 末梢知覺差，指導避免使用熱水袋或熱墊保暖。

(9) 教導病人避免長期站立或兩腿交叉。

(10) 教導病人選擇適合的彈性襪以避免靜脈鬱積。

(11) 每天監測並記錄皮膚凹陷指數。

(12) 注意已有潰瘍的傷口護理。

(13) 依醫囑按時服用藥物，降低血液黏稠。

(14) 教導勿穿太緊的衣物。

(15) 教導使用足架、水床、蛋形床墊或其它設備減輕肢體末梢的壓力。

（七）衛教指導

1. 預防跌倒須知。

2. 高血壓患者日常應注意事項。

3. 急性腦中風的護理：

主題名稱	暫時性腦缺血	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-A02	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	6/10

- (1)腦中風的危險因子：高血壓、動脈硬化性心臟疾病、糖尿病、血脂過高、肥胖、血液之黏稠性增加、脫水、家中有成員罹患血管疾病、靜止、活動性少之生活型態、慢性阻塞性肺部疾病、心臟疾病、飲酒、抽煙、服用避孕藥。
- (2)急性期之醫療處置：若有徵象及症狀發生時需立即就醫，立即臥床休息，使用抗凝血劑、抗血小板凝集劑，須控制過高之高血壓及糖尿病（於 140mg／dl 以下），維持體溫 36.5-37.5°C，維持血液氧氣濃度(PaO₂)>95%。
- (3)急性期之護理目標：在中風 48-72 小時內稱之為黃金急性期，主要目標在維持生命、預防及控制顱內壓上升、觀察血壓變化，一旦腦中風發生使血流受阻，正常生理反應機制會使血壓上升，才能維持並保有腦組織之灌流，故 75% 急性腦中風的病人有高血壓情形，若無合併頭痛、頭暈、噁心、嘔吐等不適之情形則不降壓，一般維持血壓 < 180／105mmHg，有高血壓病史者血壓 > 220／120mmHg 才會處理血壓狀況。須等黃金急性期過後再積極控制血壓。
- (4)穩定期之護理目標：約腦中風後一週，病情較穩定後復健特別重要，目標為改善活動力，預防避免肩部疼痛，維持皮膚的完整性無壓力性損傷，達到自我照顧的目的。
- (5)日常注意事項：
 - A. 飲食：
 - (a) 採低鹽、低油、低膽固醇飲食。
 - (b) 進食前應先評估吞嚥能力，由健側放入軟質食物，不給液體餵食，因肌肉收縮不協調導致吞嚥能力下降，流質食物無固定形狀易控制，容易嗆到；若食物誤吸入肺部，也大大的提高吸入性肺炎的危險，故進食時需採半坐臥，吞嚥時頸部呈屈曲。
 - (c) 若有嗆到情形，暫時禁止由口進食，需協助使用鼻胃管灌食。
 - B. 活動：
 - (a) 告知家屬協助觀察病人是否有意識突然的改變、進食是否嗆到及排泄是否順暢（6 小時內有無解尿、幾天未解便）。

主題名稱	暫時性腦缺血	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-A02	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	7/10

- (b) 注意病人安全及意識，接受情緒反應；說話需放慢速度，必要時加上手勢。
- (c) 保持安靜，勿隨便移動病人，注意保暖，可抬高頭部約 15 度。
- (d) 增進活動力預防畸形及壓力性損傷：每兩小時更換一次姿勢，至少要每天協助維持 15-30 分的俯臥姿勢，預防膝髖關節屈曲。
- (e) 維持皮膚完整性，選擇前扣衣物，衣物床單平整，預防壓力性損傷合併症。
- (f) 患肢之再訓練：指導家屬對無法活動臥床的病人執行全關節被動運動，可活動的病人鼓勵以健側協助患側活動，以維持關節活動度，每天至少執行五次，每次 10 分鐘。
- (g) 鼓勵獨立執行日常活動，日常用品置放於健側，注意患側之安全。
- (h) 穩定期時即開始復健，由醫師評估後會診復健師，開始進行復健。

(八) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

- (一) 謝明儒(2020)・2020 台灣腦中風學會與台灣急診醫學會急性缺血中風病人的院前緊急處置與急診診斷治療指引・台灣中風醫誌，2(4)，257－275。
- (二) 馮容芬譯(2020)・神經系統疾病之護理・成人內外科護理（下冊，76-89）・台北：偉華。

主題名稱	暫時性腦缺血	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-A02	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	8/10

(三) 林月春、陳筱瑤、曾建寧、葉純妤、陳美香、陳妙言、戴金英、鄧慶華、劉秀雲、陳坤鍾、王淳厚、黃邦榮、甘蜀美、吳姿蓉、林秀英(2024) • 中風復健護理，復健護理學（321-351 頁）• 台北：永大。

(四) Mendelson, S. J., & Prabhakaran, S. (2021). Diagnosis and management of transient ischemic attack and acute ischemic stroke: a review. *Jama*, 325(11), 1088-1098.

七、附件

(略)

主題名稱	暫時性腦缺血	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-A02	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	9/10

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
97.05.31	1.0	新制定	97 年 05 月 31 日護理部 照護標準委員會通過
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版	
100.08.31	2.1	修改說明內容與參考文獻	100 年 08 月 31 日護理部 照護標準委員會通過
101.08.31	2.2	1.醫護部改護理部 2.目地內容部份修辭 3.說明刪除：危險性傷害／跌倒、知識缺失 ／缺乏正確的高血壓資訊 新增：高危險性跌倒／生理因素、健康尋求 行為／自覺對健康的控制能力	101 年 08 月 31 日護理部 照護標準委員會通過
102.02.08	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進 行年度臨時檢閱	
103.06.30	3.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
103.08.31	3.1	說明內容部份修辭潤飾	103 年 08 月 31 日通過護 理部照護標準委員會。
104.08.31	3.2	1.第三項第(四)、(六)、(七)目部份內容修辭 2.第六項參考資料文獻部份內容更新	104 年 08 月 31 日護理部 照護標準委員會通過
105.08.31	3.3	新增參考文獻出處於內文中	105 年 08 月 31 日護理部 照護標準委員會通過
106.08.31	3.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.06.29	3.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.09.12	3.4	1. 第三項第一目參考資料修訂。 2. 第二項新增（含中興分院）。	107 年 09 月 12 日護理長 會議通過
108.05.15	3.5	1. 第三項第七目之 3(4)(5)B(d)壓瘡更改為壓 力性損傷。 2. 第三項第八日本辦法經委員會通過後公布 實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議 核准後公布實施。	108 年 05 月 15 日護理長 會議通過；108 年 05 月 20 日督導會議通過公布。

主題名稱	暫時性腦缺血	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-A02	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	10/10

修正日期	版本	修正說明	備註
109.08.18	3.6	第三項第六目之 7(12)(14)說明內容部份修辭潤飾	109 年 08 月 06 日照護標準組會議通過；109 年 08 月 12 日護理長會議通過；109 年 08 月 18 日督導會議通過公布。
110.08.05	3.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.09.06	3.7	1. 第三項第五目、第六目護理問題及護理措施內容部份修辭潤飾。 2. 第六項參考資料文獻部份內容更新。 3. 內文參考文獻引用刪除。	111 年 08 月 04 日照護標準組會議通過；111 年 08 月 10 日護理長會議通過；111 年 09 月 06 日督導會議通過公布。
112.09.05	3.8	1. 第三項第五目、第六目護理問題及護理措施內容部份修辭潤飾。 2. 第六項參考資料文獻部份內容更新。	112 年 08 月 03 日照護標準組會議通過；112 年 08 月 09 日護理長會議通過；112 年 09 月 05 日督導會議通過公布。
113.09.03	3.9	1. 第三項第四目之 1.(5)說明內容文字修訂。 2. 第三項第六目之 1.(8)說明內容文字修訂。	113 年 08 月 08 日照護標準組會議通過；113 年 08 月 14 日護理長會議通過；113 年 09 月 03 日督導會議通過公布。
114.10.08	4.0	1. 第三項第七目之 3.(3)說明內容文字修訂。 2. 第六項參考資料文獻部份內容更新。	114 年 08 月 07 日照護標準組會議通過；114 年 09 月 10 日護理長會議通過；114 年 10 月 08 日督導會議通過公布。